

1. Le tableau d'une décompensation hyperosmolaire diabétique comprend :

- A- Un trou anionique
- B- Une dyspnée de kussmaul
- C- Une hypernatrémie
- D- Une déshydratation
- E- Un coma

2. Le diagnostic positif d'une adénopathie superficielle se fait par :

- A- Inspection
- B- Palpation
- C- La pratique d'une radiographie thoracique
- D- La pratique d'une échographie abdominale
- E- La pratique d'un scanner thoracique

3. Le Cancer de la langue est drainé au niveau des ganglions :

- A- Axillaires droits
- B- Axillaires gauches
- C- Sous-maxillaire
- D- Sus-claviculaires gauches
- E- Epitrochléens

4. Une poly adénopathie peut se voir en cas des infections virales suivantes :

- A- Primo infection par le VIH
- B- Paludisme
- C- Infection par le CMV
- D- Rubéole
- E- Leishmaniose viscérale

5. Les adénopathies médiastinales sont fréquentes dans :

- A- maladie de vaquez
- B- lymphome de Hodgkin
- C- myélome multiple
- D- leucémie myéloïde chronique
- E- leucémie aigue lymphoblastique

6. Les IST suivantes sont habituellement responsables d'ulcérations génitales en Tunisie :

- A. La syphilis
- B. Chancre mou
- C. Lymphogranulomatose vénérienne
- D. L'herpès génital
- E. L'infection à gonocoque

7. Devant un écoulement urétral :

- A. Les deux bactéries à suspecter en premier sont *Neisseria gonorrhoeae* et *Chlamydia pneumoniae*
- B. Un examen à visée microbiologique n'est pas obligatoire avant de commencer le traitement
- C. On doit demander immédiatement les sérologies de VIH, VHB et de la syphilis
- D. On doit systématiquement essayer de prendre en charge le ou les partenaires sexuels
- E. L'antibiothérapie probabiliste repose sur l'association ciprofloxacine et acide clavulanique



8. Le traitement de 1^{ère} intention d'une urétrite repose sur les molécules suivantes :

- A. amoxicilline-acide clavulanique
- B. ciprofloxacine
- C. ceftriaxone
- D. doxycycline
- E. cotrimoxazole

9. La transmission du VIH :

- A. Dépend de la charge virale
- B. Est possible pendant la fenêtre sérologique
- C. Est favorisée par la présence d'une ulcération génitale
- D. Est faible lors de la primo-infection
- E. Est impossible lors de la phase asymptomatique

10. Au cours des œdèmes généralisés :

- A- Le diagnostic est principalement clinique
- B- Les caractéristiques de l'œdème orientent souvent l'enquête étiologique
- C- La polyurie est un élément de pronostic péjoratif
- D- Le retentissement est apprécié par la recherche de certaines localisations graves
- E- L'œdème des séreuses est inconstant

11. L'œdème de revascularisation :

- A- Apparaît en postopératoire, lié à l'hyperperméabilité capillaire ischémique
- B- Est de plus en plus fréquent
- C- Est lié au rétablissement de la pression artérielle
- D- Disparaît spontanément en sept mois
- E- Peut être dû aux blessures lymphatiques et à la tension des masses musculaires

12. Le lymphœdème :

- A- S'étend jusqu'à la distalité du membre
- B- Est initialement douloureux
- C- A une consistance élastique au stade de début
- D- Une peau suintante et une hyperkératose peuvent être des signes associés
- E- Peut être primitif ou secondaire

13 . L'œdème de stase veineuse :

- A- Peut être aigu ou chronique
- B- Est secondaire à une augmentation de la pression oncotique
- C- Est secondaire à une augmentation de la pression hydrostatique
- D- Peut être consécutif à un obstacle incomplet au drainage lymphatique ou veineux
- E- Peut être secondaire à une compression veineuse tumorale



14. Le vaccin contre la rougeole :

- A. C'est un vaccin vivant
- B. Peut être associée à la vaccination contre les oreillons
- C. Une seule dose suffit
- D. Doit être pratiqué avant l'âge d'un an
- E. Peut provoquer une réaction fébrile

15. Le vaccin BCG :

- A. Est un vaccin vivant
- B. Est administré à l'âge de 1an
- C. son efficacité est jugée sur l'IDR
- D. Peut se compliquer d'une adénite
- E. Peut être associé à un autre vaccin

16. Parmi les diagnostics différentiels d'une splénomégalie, vous reprenez :

- A- Un gros rein gauche
- B- Une tumeur de la queue du pancréas
- C- Une tumeur de la surrénale droite
- D- Un cancer gastrique
- E- Une tumeur de l'angle colique gauche

17. Au cours d'une splénomégalie infectieuse bactérienne, vous pouvez noter :

- A- Une porte d'entrée est souvent retrouvée
- B- Un syndrome septicémique
- C- Un syndrome inflammatoire biologique franc
- D- Un état général conservé
- E- Une hépatomégalie constante

18. Une splénomégalie fébrile avec leuconéutropénie vous évoque :

- A- Une brucellose
- B- Une fièvre typhoïde
- C- Une candidose viscérale
- D- Une mononucléose infectieuse
- E- Une rickettsiose

19. L'imagerie au cours d'une splénomégalie est indiquée si :

- A- Abscès splénique
- B- Candidose splénique
- C- Maladie de Gaucher
- D- Signes d'hypertension portale
- E- Lupus érythémateux systémique

20. Les motifs d'hospitalisation en Urologie d'une colique néphrétique sont

- A. Colique néphrétique hyperalgique
- B. Colique néphrétique hyperthermique



20. Les motifs d'hospitalisation en Urologie d'une colique néphrétique sont

- A. Colique néphrétique hyperalgique
- B. Colique néphrétique hyperthermique
- C. Colique néphrétique simple
- D. Colique néphrétique avec insuffisance rénale aiguë
- E. Colique néphrétique sur rein unique

21. Quelles sont les propositions exactes concernant les IRA organiques

A- La présence d'une leucocyturie associée oriente plutôt vers une néphropathie interstitielle aiguë (NIA)

B- La présence d'une HTA et d'œdèmes associés orientent vers une nécrose tubulaire aiguë (NTA)

C- La présence d'une hématurie macroscopique associée est spécifique d'une néphropathie vasculaire aiguë (NVA)

D- La présence d'une protéinurie > 2 g/24h associée oriente vers une néphropathie glomérulaire aiguë (NGA)

E- La présence d'une hématurie microscopique associée oriente vers une

22. Dans une insuffisance rénale aiguë par nécrose tubulaire aiguë :

A -La récupération de la fonction rénale antérieure est la règle

B- L'hyperhydratation intracellulaire peut entraîner des crises convulsives

C - Il existe une hématurie macroscopique

D -Une IRA fonctionnelle peut évoluer vers une nécrose tubulaire aiguë en l'absence de traitement

E - La protéinurie est supérieure à 1,5 g/24 h

23. Une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle peut être due à :

A - une toxicité à la gentamicine

B - Une diarrhée abondante

C - une décompensation oedémato-ascitique d'une cirrhose hépatique

D - Un traitement diurétique

E – poussée d'insuffisance cardiaque

24- Parmi les mesures préventives de la néphrotoxicité aux produits de contraste iodés, une est fautive, laquelle ?

A- l'arrêt des médicaments néphrotoxiques

B- l'arrêt des antidiabétiques oraux

C- assurer un bon état d'hydratation

D- l'utilisation de faibles doses de produit de contraste iodé

E- l'utilisation de la N-Acétyl-Cystéine

25. En cas d'hypercalcémie, l'ECG peut montrer :

A. Une tachycardie ventriculaire

B. Un bloc de branche droit

C. Un allongement du segment ST

D. Une fibrillation auriculaire

E. Des extrasystoles ventriculaires



26. Les deux causes les plus fréquentes d'une hypercalcémie sont :

- A. Une hyperparathyroïdie
- B. Une sarcoïdose
- C. Une intoxication à la vitamine D
- D. Une néoplasie
- E. Une hypercalcémie hypocalciurie familiale

27. Le myélome multiple :

- A. Est associé dans 70% des cas à une hypercalcémie
- B. Est évoquée devant des douleurs osseuses chez un sujet âgé
- C. Doit faire chercher une cytolyse, une hyponatrémie et une anémie
- D. Peut montrer un aspect poivre et sel du crâne
- E. Est retenue devant une plasmocytose > 20% au myélogramme

28. Une hypercalcémie peut être secondaire à :

- A. Une immobilisation prolongée
- B. Une hypothyroïdie
- C. Une insuffisance surrénalienne aiguë
- D. Un diabète insulino-dépendant
- E. Un phéochromocytome

29. L'atteinte rénale observée au cours d'une hypercalcémie peut être :

- A. Une néphrocalcinose
- B. Une insuffisance rénale obstructive
- C. Un syndrome polyuro-polydipsique
- D. Une hématurie
- E. Une alcalose tubulaire

30. Avant tout examen complémentaire radiologique, on peut suspecter l'origine glomérulaire d'une hématurie macroscopique sur :

- A- La présence de caillots
- B- Une leucocyturie égale à 50 000 éléments par minute
- C- Une protéinurie de 3 g / 24h
- D- Une scintigraphie rénale isotopique anormale
- E- Le caractère normal du cliché de l'appareil urinaire sans préparation

31. Un garçon de 10 ans présente à 3 reprises des hématuries macroscopiques et ce de façon concomitante à des angines. Les examens ont montré que 70% des hématies sont de morphologie déformée à l'examen microscopique des urines. Il est pertinent de demander :

- A- Une urographie avec lavage au Lasilix*
- B- Une cystographie



- B- Une cystographie
- C- Une créatininémie
- D- Une électrophorèse des protides plasmatiques
- E- Un dosage de la protéinurie des 24 heures

32. Une hématurie d'origine glomérulaire peut être expliquée par l
pathologies suivantes:

- A- Une néphropathie à IgA
- B- Une néphropathie diabétique
- C- Une polykystose rénale autosomique dominante
- D- Une lésion glomérulaire minime
- E- Une glomérulonéphrite membrano-proliférative

33. Une hyperkaliémie par transfert peut s'observer en cas de :

- A- Transfusion sanguine
- B- Rhabdomyolyse
- C- Hémolyse
- D- Intoxication digitalique
- E- Acidose métabolique

34. Les causes possibles d'hyperkaliémie sont

- A. Insuffisance surrénale aiguë
- B. Hyper-aldostéronisme primaire
- C. Insuffisance rénale aiguë
- D. Vomissements
- E. Acidose métabolique aiguë

35. Quelles sont parmi les anomalies suivantes celles qui évoquent déshydratation extracellulaire :

- A- Langue sèche
- B- Protidémie élevée
- C- Hypernatrémie
- D- Pli cutané persistant
- E- Hypotension orthostatique

36. On évoque une déshydratation intracellulaire devant :

- A- Soif
- B- Hypoprotidémie
- C- Hypernatrémie
- D- Elévation de l'hématocrite
- E- Hyperosmolarité

37. L'alcalinisation par du bicarbonate de sodium doit être envisagée :

- A- Systématiquement devant une acidocétose diabétique
- B- Devant toute acidose lactique
- C- Devant une acidose métabolique sévère avec instabilité hémodynamique
- D- Devant une acidose respiratoire
- E- Devant une acidose métabolique sévère avec instabilité



E- Devant une acidose métabolique avec hyperkaliémie menaçante

38. Les manifestations de l'alcalose métabolique peuvent comporter selon sa sévérité :

- A- Une hyperventilation alvéolaire
- B- Des crises convulsives
- C- Des crises de tétanie
- D- Une hyperkaliémie
- E- Des troubles du rythme cardiaque

39. L'alcalinisation au cours de l'acidose métabolique peut être à l'origine d'une :

- A- acidose tissulaire paradoxale
- B- hypoxie tissulaire
- C- hypocapnie
- D- hypercalcémie
- E- crise de tétanie

40. Une mauvaise tolérance à une anémie peut se traduire par :

- A- Une dyspnée d'effort
- B- Un souffle systolique
- C- Une polypnée
- D- Une douleur thoracique
- E- Des urines foncées

41. Le paramètre suivant est utile pour distinguer une anémie par carence martiale d'une anémie inflammatoire

- A- VGM
- B- Fer sérique
- C- Ferritinémie
- D- Vitesse de sédimentation
- E- Numération des plaquettes

42. Une anémie normocytaire doit faire rechercher :

- A- une insuffisance rénale
- B- une hypothyroïdie
- C- une cirrhose
- D- un syndrome inflammatoire
- E- un éthyisme

43. La découverte sur un hémogramme, chez une jeune de 17 ans, d'une augmentation du nombre des hématies, avec un VGM à 65 fl et un taux d'hémoglobine à 12 g/dl doit conduire à :

- A- un dosage de la ferritinémie
- B- une mesure de la CRP
- C- une électrophorèse de l'hémoglobine
- D- une fibroscopie gastrique
- E- un examen gynécologique



C- une élévation de l'hémoglobine

- D- une fibroscopie gastrique
- E- un examen gynécologique

44. Le PFC

- A- Doit être isogroupe ABO
- B- Doit être isogroupe Rh
- C- N'a pas besoin d'être cross-matché
- D- Contient tous les facteurs de coagulation à l'exception des plaquettes
- E- Quand le groupe du receveur n'est pas connu l'idéal est de transfuser du PFC du groupe AB.

45. Le syndrome de détresse respiratoire aigüe post-transfusionnel (TRALI) :

- A- survient dans les 6 heures suivant la transfusion
- B- n'est causé que par la transfusion de PFC
- C- est la complication transfusionnelle immédiate la plus fréquente
- D- doit être traité par de fortes doses de corticoïdes
- E- est souvent dû à une donneuse de sang multipare

46. Une mauvaise tolérance à une transfusion peut se traduire par :

- A- une hyperthermie
- B- une hémorragie
- C- des éternuements
- D- un collapsus
- E- un hoquet

47. Une transfusion massive peut être à l'origine des complications suivantes :

- A- une hypothermie
- B- une hypocalcémie
- C- une hyperkaliémie
- D- une hyponatrémie
- E- une acidose

48. Les signes cliniques d'une intoxication aigüe aux organophosphorés sont :

- A. Encombrement bronchique
- B. Constipation
- C. Bradycardie
- D. Bronchodilatation
- E. Vomissements

49. Quel est le traitement spécifique de l'intoxication aigüe par les organophosphorés ?

- A. Administration d'atropine
- B. Assistance ventilatoire
- C. Charbon activé
- D. Correction des troubles hydro-électrolytiques
- E. Administration des réactivateurs de l'acétylcholinestérase



50. L'intoxication au monoxyde de carbone (co) :

- A. Est une intoxication grave
- B. Peut se révéler par des troubles psychiques
- C. Est confirmée par la détermination de la PAO₂ et de la saturation de l'hémoglobine en oxygène
- D. Peut être à l'origine d'une hyperthermie
- E. Est traitée par une oxygénothérapie à faible débit

51. Les signes cliniques d'une intoxication aiguë aux benzodiazépines :

- A. Une dépression respiratoire
- B. Des convulsions
- C. Une hypotension
- D. Un trouble de la conscience
- E. Une diminution des sécrétions

52. Les fractures ouvertes de jambe peuvent être classées type 2 de Cauchois et Duparc avec :

- A. Une plaie de plus de 8 cm
- B. Des plaies multiples délimitant un lambeau cutané douteux
- C. Une perte de substance cutanée
- D. Un décollement cutané
- E. Une dilacération de l'aponévrose et du périoste

53. Dans les fractures de jambe, une complication vasculaire est à redouter particulièrement en cas de :

- A. Fracture métaphysaire proximale
- B. Fracture Spiroïde
- C. Fracture ouverte Cauchois 2
- D. Fracture du col du péroné
- E. Fracture très déplacée

54. La prise en charge d'une fracture ouverte de jambe à la salle d'urgence comprend :

- A. Un parage de la plaie
- B. Un pansement de la plaie
- C. La mise en place d'une attelle
- D. Une antibiothérapie par voie IV
- E. Une immobilisation par fixateur externe

55. Le traitement d'une fracture ouverte type 3B de Cauchois comprend

- A. Un parage de la plaie
- B. La mise en place d'un fixateur externe
- C. Des pansements répétés
- D. Une antibiothérapie pendant 10 jours
- E. Une greffe de peau mince secondaire

56. Au cours du traumatisme crânien grave :

- A. L'hypotension et l'hypoxie sont délétères
- B. L'emploi d'antihypertenseurs est recommandé si la PAS, est supérieure à 160 mmHg



supérieure à 160 mm Hg.

C. La ventilation mécanique doit être systématique si le score de Glasgow est inférieur à 8.

D. Une diminution de la pression de perfusion cérébrale induit une vasoconstriction cérébrale tant que l'autorégulation est conservée.

E. L'anisocorie signe un engagement cérébral.

57. Concernant les ACSOS dans le TC grave :

A. Une hyperthermie d'origine infectieuse aggrave les lésions cérébrales car elle augmente les besoins métaboliques du cerveau.

B. Un traitement symptomatique de l'hyperthermie n'a pas d'intérêt.

C. Les troubles métaboliques sont souvent d'origine iatrogène.

D. Une anémie profonde doit être corrigée et doit faire rechercher une cause lésionnelle associée.

E. L'hypotension et l'hypoxie à la phase aigüe sont les principaux facteurs pronostics

58. Les principales causes d'une insuffisance respiratoire aigüe chez un traumatisé grave sont :

A. Traumatisme thoracique

B. Atteinte médullaire cervicale

C. Traumatisme facial

D. Traumatisme crânien grave

E. Pneumopathie communautaire

59. Dans le choc hémorragique, la triade létale comporte :

A. Hypothermie

B. Hypocalcémie

C. Anémie

D. Acidose

E. Coagulopathie

60. La prise en charge du choc hémorragique impose

A. Transfusion sanguine

B. Remplissage vasculaire abondant

C. Contrôle du saignement

D. Catécholamines

E. Réchauffement

61. La prise en charge d'un choc hémorragique chez un patient âgé de 35 ans et qui présente une contusion abdominale associée à des traumatismes périphériques fermés doit comporter :

A. Remplissage vasculaire par 1000 à 1500 ml de cristalloïdes

B. Remplissage vasculaire par 3000 ml de cristalloïdes

C. Recours aux catécholamines

D. Transfusion par des produits sanguins labiles

E. Ostéosynthèse des fractures périphériques



62. Parmi les médicaments suivants, quels sont les antalgiques de palier 1 ?

- A- Néfopam
- B- Chlorhydrate de tramadol
- C- Kétoprofène
- D- Aspégic
- E- Piroxicam

63. Choisissez les antalgiques de niveau 3 :

- A- Chlorhydrate de tramadol
- B- AINS
- C- Fentanyl
- D- Codéine
- E- Morphine

64. En cas d'antécédent d'ulcère gastrique, quels antalgiques on préfère utiliser ?

- A- Ibuprofène
- B- Tramadol
- C- Paracétamol
- D- Diclofénac
- E- Morphine

65. Choisissez les effets indésirables des AINS

- A- Dépression respiratoire
- B- Epigastalgies
- C- Epistaxis
- D- Insuffisance rénale
- E- Bronchospasme

66. Concernant l'arrêt cardiaque

- A. Un sujet en arrêt cardiaque est un sujet inconscient qui ne respire absence de pouls central
- B. La vérification de la respiration se fait par la méthode VES pendant 30 secondes
- C. La respiration agonique est un signe de vie
- D. Le diagnostic positif de l'arrêt cardiaque est un diagnostic clinique
- E. Si le patient ne présente aucun signe de vie, la RCP doit être débuté immédiatement

67. Au cours d'un arrêt cardiaque

- A. La fibrillation ventriculaire est un rythme choquable qui nécessite l'administration d'un CEE
- B. L'asystolie est un rythme choquable qui nécessite l'administration d'un CEE
- C. L'adrénaline doit être administrée dès le début dans tous les cas
- D. L'amiodarone est un stabilisateur de membrane qui est indiqué après



E. L'amiodarone à la dose de 300 mg est indiqué après le troisième choc

68. La défibrillation au cours d'un arrêt cardiaque

A. L'énergie indiquée est 360 J en mode monophasique et 200 J en mode biphasique

B. Le mode utilisé doit être asynchrone

C. Les palettes sont placées sur le thorax : une au-dessous de la clavicule gauche à côté du sternum et une sous axillaire droite en basithoracique.

D. Après le choc on doit reprendre immédiatement le massage cardiaque sans interpréter le rythme

E. Est indiqué si le rythme indique une activité électrique sans pouls

69. Au cours de l'hyperthyroïdie on peut observer :

A. une leuconéutropénie

B. une hypocholestérolémie

C. une hypocalcémie

D. une cytololyse

E. une tendance à l'hyponatrémie

70. Une hyperthyroïdie trainante, non traitée chez une femme de 55 ans compliquer de :

A. une ostéoporose

B. une psychose délirante

C. une paralysie musculaire

D. un bloc auriculo-ventriculaire

E. des accès maniaques

71. Une hypothyroïdie congénitale :

A. Est une maladie rare de l'enfant

B. Est souvent d'origine centrale

C. Peut être due à une carence maternelle en iode

D. Se déclare dès la naissance dans plus de 90% des malades

E. Entraîne des troubles neurologiques réversibles

72. Une hypothyroïdie doit être recherchée chez tout patient consultant pour :

A. Anémie macrocytaire

B. Galactorrhée

C. Hypertension artérielle systolique

D. Crampes musculaires

E. Arthralgies

73. Le coma myxoedémateux :

A. Peut-être déclenché par une infection

B. Est associé à une bradycardie

C. Est un coma agité

D. Est associé à une bradypnée

E. Est de bon pronostic



Cas clinique 1 :

Une patiente âgée de 35 ans consulte pour diabète. Elle est mariée et a mené 2 grossesses il y a 10 ans et suit une contraception hormonale. Depuis la période de confinement, elle signale l'apparition d'un syndrome polyuro-polydipsique négligé par la patiente l'amenant à boire des sodas. Elle est hypertendue depuis 3 ans traitée par diurétiques. Elle fume 1 paquet par jour. Sa dernière visite médicale il y a 2 ans montrait : glycémie à jeun : 6,3 mmol/l ; IMC à 36 ; tour de taille : 108 cm.

Elle est inquiète car son père âgé de 58 ans a eu récemment un AVC.

Son examen actuel montre : IMC : 32 ; TA : 15/10 cm Hg ; tour de taille : 104 cm ; glycémie : 9mmol/l ; kaliémie : 3,2 mmol/l ; hémoglobine glyquée : 8%.

74. L'état de cette patiente il y a 2 ans correspondait à :

- A- Un diabète patent
- B- **Un syndrome métabolique**
- C- **Un prédiabète**
- D- Une tolérance glucidique normale
- E- Un diabète gestationnel

75. Depuis cette date, cette patiente aurait pu éviter cette situation en :

- A- **Augmentant son activité physique**
- B- **Choisissant un autre mode de contraception**
- C- Prenant l'insuline
- D- **Evitant les sodas**
- E- **Modifiant son traitement diurétique**

76. Le traitement de cette patiente doit inclure :

- A- **Un régime hypocalorique**
- B- **Une supplémentation de potassium**
- C- **Une marche quotidienne de 30 mn**
- D- **Des biguanides**
- E- Une bithérapie metformine sulfamides

Cas clinique 2 :

Un patient âgé de 28 ans est adressé au décours d'un IDM pour évaluation métabolique. Il n'a pas de maladie connue ; il fume 1 paquet par jour et boit de l'alcool. Son examen montre : IMC : 28 ; tour de taille : 104 cm ; TA : 120/80 mm Hg ; absence de xanthomes. Son exploration montre : Glycémie : 5 mmol/l ; LDL-C calculé : 2 g/l ; triglycérides : 3 g/l ;

77. Vous évoquez chez ce patient une hyper lipoprotéïnémie de type :

- A- I
- B- II a
- C- **II b**
- D- III
- E- IV

78. Son état lipidique peut être amélioré par :

- A- **Une perte de poids**



- A- Une perte de poids
- B- L'arrêt de l'alcool
- C- L'arrêt du tabac
- D- Un régime sans sel
- E- L'activité physique

Sous ces mesures et 40 mg d'atorvastatine, le patient présente un LDL-cholestérol à 0,7 g/l et des triglycérides à 2,5 g/l.

79. Vous décidez de :

- A- Ajouter un fibraté
- B- Associer l'ézétimibe
- C- Augmenter la dose d'atorvastatine
- D- Associer des acides oméga-3
- E- Associer des inhibiteurs des PCSK-9

Cas clinique 3 :

Patiente âgée de 18 ans, sans antécédents, consulte pour des polyarthralgies et des douleurs abdominales évoluant depuis une semaine. A l'examen : apyrétique + des lésions érythémato-violines ne s'effaçant pas à la vitropression, polymorphes, nécrotiques par endroit, infiltrées, prédominant aux membres inférieurs. Il n'y avait pas d'arthrite avec un abdomen discrètement sensible en péri-ombilical. Le reste de l'examen physique est sans particularités. La NFS, la créatinine et la fonction hépatique sont normales. La bandelette urinaire : Protéinurie positive à deux croix.

80. L'éruption cutanée évoque un purpura, l'origine vasculaire semble probable devant :

- A. L'absence de fièvre
- B. Le caractère nécrotique
- C. L'aspect polymorphe des lésions
- D. La localisation aux membres inférieurs
- E. La douleur abdominale associée

81. Le diagnostic à évoquer en premier lieu chez cette patiente est :

- A. Une périartérite noueuse
- B. Une amylose
- C. Un purpura Rhumatoïde
- D. Une infection virale
- E. Une cryoglobulinémie

82. La biopsie cutanée avec IFD serait en faveur de votre hypothèse si elle montre :

- A. Un infiltrat lymphocytaire péri-vasculaire
- B. L'absence de nécrose fibrinoïde
- C. Une extravasation des globules rouges à travers la paroi vasculaire
- D. Un dépôt d'immunoglobuline A à l'IFD
- E. Un dépôt d'immunoglobuline G à l'IFD



Cas clinique 4 :

Une femme de 28 ans se présente pour des polyarthralgies des mains et des pieds évoluant depuis 12 semaines. Elle est réveillée la nuit par les douleurs et se plaint également d'un dérouillage matinal de 60 mn. Elle rapporte aussi la notion de xérophtalmie. L'examen clinique montre un gonflement du poignet droit, de la 2ème métacarpo-phalangienne (MCP) des 2 mains ainsi qu'une douleur bilatérale à la pression transverse des MCP et des métatarso-phalangiennes (MTP). Vous suspectez une polyarthrite rhumatoïde (PR).

83. Quels sont les deux autres diagnostics à évoquer ?

- A- lupus
- B- arthrose des mains
- C- syndrome de Gougerot- Sjogren primitif
- D- goutte
- E- pseudopolyarthrite rhizomélique

84. Quels examens complémentaires permettent d'orienter le diagnostic de PR ?

- A- Anticorps anti-Scl70
- B- Facteur rhumatoïde
- C- Un scanner thoracique
- D- Anticorps anti-CCP
- E- Une échographie des mains

85. Vous réalisez des radiographies des mains et des avants pieds. Quels sont les signes en faveur de la PR ?

- A- Géodes juxta articulaires
- B- Erosions
- C- Pincement de l'interligne articulaire
- D- Ostéophytes
- E- Calcifications intra-articulaire

86. Quels sont les éléments de mauvais pronostic chez votre patiente ?

- A/ le nombre important d'articulations gonflées
- B/ le syndrome inflammatoire marqué
- C/ la présence de destruction radiologique à un stade précoce d'évolution
- D/ l'absence de facteur rhumatoïde
- E/ la présence d'un squeeze test des MCP

Cas clinique 5 :

Un patient âgé de 30 ans, sans antécédents pathologiques, consulte pour céphalées avec fièvre et vomissements évoluant depuis 24 heures. Examen : conscient bien orienté, raideur de la nuque, TA 12/7, T° 40°C, pas de signes de localisation neurologiques, pas de taches purpuriques.

Ponction lombaire : liquide trouble, leucocytes 500/mm³, 80% PMN, examen direct : cocci à Gram négatif, glycorachie 1 mmol/L (glycémie 5 mmol/L), protéinachie 1.5 g/L



examen direct : cocci à Gram negatif, glycorachie 1 mmol/L (glycémie 5 mmol/L), protéinorachie 1,5 g/L.

87. Ce patient présente :

- A- une méningite à formule mixte
- B- une méningite normoglycorachique
- C- une méningite normoprotéinorachique
- D- une méningite purulente**
- E- un méningisme

88. Le microorganisme à suspecter en premier chez ce patient est :

- A- *Neisseria gonorrhoeae*
- B- *Neisseria meningitidis***
- C- *Staphylococcus aureus*
- D- *Streptococcus pneumoniae*
- E- *Streptococcus pyogenes*

89. L'antibiothérapie à prescrire en 1^{ère} intention chez ce patient est :

- A- ampicilline
- B- céfotaxime**
- C- gentamicine
- D- pénicilline G
- E- vancomycine

90. En plus de l'antibiothérapie, une corticothérapie par la molécule suivante est à prescrire :

- A- hydrocortisone
- B- dexaméthasone**
- C- méthylprednisolone
- D- prednisolone
- E- prednisone

Cas clinique 6 :

Mme S âgée de 53 ans consulte aux urgences pour des douleurs abdominales avec vomissements depuis 48h. Dans ses antécédents, on trouve une tuberculose pulmonaire traitée il y a 3 ans, une cholécystectomie il y a 4 ans. L'interrogatoire retrouve la notion d'un amaigrissement de 12 kg en 4 mois, une asthénie importante gênant les activités quotidiennes. L'examen clinique objective une TA à 80/60 mm Hg, une fréquence cardiaque à 110 bat/min, un pli cutané persistant abdominal, le visage et le décolleté ainsi que sa cicatrice d'appendicectomie sont hyperpigmentés. Le bilan : NFS : Hb10g/dl, VGM 89, Ht49%, GB 10000/mm³, Na+123mmol/L, K+5,8 mmol/l, créatinine : 143μmol/l, urée 17μmol/l, glycémie : 0,6g/l. Radio thorax : séquelles de tuberculose au niveau du lobe supérieur gauche. Vous évoquez une décompensation surrénalienne aiguë d'une insuffisance surrénalienne lente.

91. Les signes cliniques qui plaident en faveur de la présence d'une insuffisance surrénalienne chronique antérieure à l'épisode aigu sont :

- A. Hyperpigmentation**



Insuffisance surrénalienne chronique antérieure à l'épisode aigu sont :

- A. **Hyperpigmentation**
- B. Les douleurs abdominales
- C. Vomissements
- D. **Amaigrissement**
- E. Collapsus cardiovasculaire

92. Quel examen faut-il demander en urgence pour confirmer le diagnostic de l'insuffisance surrénalienne ?

- A. **Cortisol plasmatique**
- B. Cortisol libre urinaire
- C. aldostérone
- D. Test au Synacthène
- E. Test hypoglycémie insulinique

93. La prise en charge de cette patiente comporte :

- A. **Perfusion de sérum glucosé à 5% en IV**
- B. Supplémentation potassique en IV
- C. **supplémentation de sodium en IV**
- D. **Bolus d'hémisuccinate d'hydrocortisone**
- E. Antibiothérapie

Cas Clinique 7 :

Madame B., 35 ans, sans antécédent particulier consulte pour une douleur apparue brutalement la veille au niveau de la fosse lombaire droite avec irradiation en fosse iliaque droite. La patiente signale de plus un épisode de vomissement ce matin. Ses constantes à l'arrivée aux Urgences sont : TA = 154/70, FC = 105 battements/min, Température = 37,8 °C.

Biologie: NFS: Hb: 12g/dL; GB:6000/ mm³; plq: 150000/mm³, Créatinémie: 80µmol/l. Dosage sanguin des HCG est négatif.

94. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques ?

- A. **Appendicite aiguë**
- B. **Torsion d'annexe**
- C. **Colique hépatique**
- D. Sigmoidite diverticulaire
- E. **Colique néphrétique**

Une échographie faite en urgence a montré la présence d'une dilatation urétéro pyélo calicelle droite, une TDM SPC réalisée a montré la présence d'un calcul urétéral pelvien de 5 mm avec une densité 300 UH.

95. Quelle est votre conduite à tenir ?

- A. **Anti-inflammatoires non stéroïdiens par voie intraveineuse**
- B. **Restriction hydrique**
- C. Antispasmodiques par voie intraveineuse
- D. Drainage chirurgical des urines
- E. Tamassage des urines

Après une sédation provisoire de la douleur, la patiente revient 24 heures plus tard avec une température à 39.2°C et une défense de la fosse lombaire droite.



96. Quelle est votre conduite à tenir en urgence ?

- A. Double antibiothérapie parentérale
- B. Mesures de réanimation
- C. Ponction sus-pubienne
- D. Néphrostomie percutanée
- E. LEC en urgence

97. Quelle est l'origine la plus probable du calcul ?

- A. Oxalo-calcique
- B. Phosphocalcique
- C. Acide urique
- D. Cystinique
- E. Phospho ammoniaco magnésienne

Cas clinique 8 :

Un homme de 32 ans, opéré d'une insuffisance aortique il y a deux ans, est porteur d'une prothèse valvulaire mécanique. Il se soumet à une surveillance régulière.

Son état est satisfaisant et l'auscultation (depuis l'intervention) était celle normalement rencontrée chez un porteur de prothèse aortique.

Depuis une extraction dentaire réalisée 3 semaines auparavant, il présente une fièvre à 38,5 degrés avec une asthénie.

98. Parmi les éventualités suivantes, vous évoquez en premier

- A. embolie pulmonaire
- B. péricardite aiguë
- C. infarctus du myocarde
- D. endocardite infectieuse
- E. dissection aortique

99. L'un des éléments suivants, s'il est retrouvé à l'auscultation, possède une grande valeur d'orientation diagnostique

- A. Une arythmie
- B. Un frottement péricardique
- C. Un souffle systolique
- D. Un bruit de galop
- E. L'apparition d'un souffle diastolique

100. Parmi les examens biologiques suivants, on doit demander en priorité

- A. Numération formule sanguine
- B. Hémocultures
- C. Amylasémie
- D. Enzymes cardiaques
- E. Gaz du sang

101. Le traitement antibiotique qui vous semble le plus logique en première intention est

- A. Ampicilline
- B. Ampicilline + Oxacilline + gentamicine
- C. Vancomycine



- C. Vancomycine
- D. Oxacilline + gentamicine
- E. Aucun traitement en attendant le résultat des hémocultures

Cas clinique 9 :

Un garçon de 6 ans est amené aux urgences pour une boiterie. La température est à 39,5. Le genou est gonflé, douloureux à la mobilisation. Il n'y a pas de douleur à la palpation des métaphyses osseuses. Vous évoquez une arthrite septique du genou.

102. Les examens d'imagerie à demander sont

- A. Radiographie du genou
- B. Echographie du genou
- C. TDM du genou
- D. Radiographie du thorax
- E. IRM du genou

103. On confirme le diagnostic

- A. Par le dosage de la VS et de la CRP
- B. Par ponction du genou et examen bactériologique
- C. Par l'hyperleucocytose à la NFS
- D. Par des hémocultures
- E. Par la numération des lymphocytes dans le liquide articulaire

104. Votre conduite thérapeutique comporte :

- A. Une antibiothérapie
- B. Une ponction lavage du genou
- C. Un drainage chirurgical
- D. Une corticothérapie
- E. Une immobilisation par plâtre circulaire

Cas clinique 10 :

Un jeune de 17 ans, moto cycliste roulant à grande vitesse, non casqué, a été heurté par un camion avec éjection. Il était ramassé par des témoins et acheminé aux urgences. L'examen au service des urgences trouve : un patient inconscient. Pas de réponse verbale, il n'ouvre pas les yeux à la stimulation douloureuse avec une réponse motrice en flexion. Il a une asymétrie pupillaire. La pupille gauche est à 5 mm et elle est non réactive. Sa respiration est ample. Sa saturation à l'air ambiant est=87%. La TA=170 /80. Le pouls est irrégulier avec des accès de tachycardie. Il n'existe pas de signes de choc. L'examen du cuir chevelu retrouve une plaie de 15cm temporale déchiquetée et un enfoncement localisé. Le reste de l'examen est sans anomalies apparentes.

105. Calculer le GCS du patient :

- A. GCS=3
- B. GCS=5
- C. GCS=8
- D. GCS=6
- E. GCS=7

106. Les éléments anamnestiques et cliniques de gravité retrouvés chez



106. Les éléments anamnestiques et cliniques de gravité retrouvés chez ce patient sont :

- A. Le mécanisme violent de l'accident
- B. La taille de la plaie du cuir chevelu
- C. La suspicion clinique d'embarrure
- D. L'anisocorie
- E. L'âge du patient

107. Les objectifs thérapeutiques de la neuro réanimation de ce patient sont :

- A. TAS > ou égale à 130 mm hg
- B. TAS sup ou égale à 120 mm hg
- C. Une Pa CO₂ autour de 35mm hg
- D. une SaO₂ > 98 %
- E. PaO₂ > 80 mm hg

108. Les agressions cérébrales secondaires d'origine centrale à craindre sont :

- A. L'HTIC
- B. L'hypotension
- C. L'œdème cérébral
- D. L'hypoxie
- E. L'anémie

Cas clinique 11 :

Mr Mohamed âgé de 25 ans, a été victime d'un accident de travail suite à une brûlure par un courant électrique de haut voltage. Il a été amené aux urgences par ses collègues. A l'examen, il présentait des brûlures circulaires de 3^{ème} degré au niveau du membre supérieur gauche ; et des brûlures de 2^{ème} degré profond au niveau de la face antérieure et postérieure du tronc.

109. Les facteurs de gravité chez ce patient sont

- A. L'âge
- B. Le courant de haut voltage
- C. L'étendue des brûlures
- D. La brûlure du tronc
- E. La présence des brûlures de 3^{ème} degré

110. Les complications qui peuvent engager le pronostic vital à court terme chez ce patient

- A. Un Choc septique
- B. Un choc hypovolémique
- C. Des troubles du rythme
- D. Un syndrome de détresse respiratoire aigue (SDRA)
- E. Une hyperkaliémie

111. Le geste à réaliser en priorité chez ce patient est

- A. Antalgique topique
- B. Escarrotomies



- C. Sulfadiazine d'argent
- D. Fasciotomie du membre supérieur**
- E. Pansement stérile

112 . Les éléments de surveillance cliniques et paracliniques chez ce patient

- A. La pression artérielle**
- B. La Glycémie
- C. La diurèse**
- D. L'ionogramme**
- E. Le bilan hépatique

Cas clinique 12 :

Mr A Y, âgé de 53 ans, alcool-tabagisme, est suivi pour DNID sous Daonil et Insulatard avec une mauvaise observance thérapeutique. Il consulte aux urgences pour fièvre, toux grasse, asthénie majeure, dyspnée et douleur thoracique gauche en coup de poignard évoluant depuis trois jours et non améliorés par du doliprane.

L'examen clinique aux urgences a trouvé : patient fébrile à 39°6 C avec des sueurs, PA 95/50 mm Hg, FC à 135/mn, FR à 35/mn, SpO2 à 87% en air ambiant.

L'auscultation pulmonaire a trouvé : des râles crépitants au niveau de la base gauche avec un petit souffle tubaire. L'auscultation cardiaque n'a pas trouvé de souffle cardiaque.

113. Quelle est la cause la plus probable de cette dyspnée ?

- A. Une embolie pulmonaire
- B. Un pneumothorax
- C. Une pneumopathie communautaire aigue**
- D. Une pneumopathie nosocomiale
- E. Un œdème aigu du poumon

Le patient a été mis sous MHC 10 L /min avec perfusion de 500ml de G5%. Une radiographie thoracique a été réalisée en urgence.

La réévaluation clinique 30 minutes plus tard a trouvé : patient somnolent, PAS à 60 mm Hg, PAD à 35, FC à 140/mn, FR à 40/mn, SpO2 à 65% et des marbrures étendues.

114. A ce stade, quelles sont les mesures thérapeutiques urgentes ?

- A. scanner thoracique en urgence
- B. appel du réanimateur**
- C. remplissage vasculaire par 30 ml/kg de sérum physiologique**
- D. intubation orotrachéale et ventilation mécanique**
- E. remplissage vasculaire par 30ml/kg d'hydroxyethylamidon (HEA)

115. Quelles erreurs relevez-vous de cette prise en charge initiale ?

- A. la réalisation d'une radiographie thoracique en urgence
- B. le retard d'antibiothérapie**
- C. le retard de remplissage vasculaire**
- D. l'absence de mise en place de voie veineuse centrale



- D. l'absence de mise en place de voie veineuse centrale
E. la mise du patient sous oxygène au masque

116. La prise en charge hémodynamique de ce malade doit comporter :

- A. Optimisation de la volémie
B. Introduction de Noradrénaline pour obtenir une PAM ≥ 65 mm Hg
C. Introduction de dopamine pour obtenir une PAS à 110 mm Hg
D. Mise en place d'une voie veineuse centrale
E. Mise en place d'un cathéter artériel

Cas clinique 13 :

Une patiente âgée de 40 ans, sans antécédents pathologiques, consulte pour brûlures mictionnelles avec pollakiurie évoluant depuis 3 jours sans fièvre ni douleur lombaire. Examen physique : normal.

117- Le premier diagnostic à évoquer chez cette patiente est

- A- cystite aiguë à risque de complication
B- cystite aiguë simple
C- lithiase urinaire
D- pyélonéphrite aiguë simple
E- vulvo-vaginite

118- L'examen complémentaire à réaliser en 1^{ère} intention est

- A- AUSP
B- ECBU
C- bandelette urinaire
D- échographie de l'appareil urinaire
E- échographie pelvienne

119- L'antibiothérapie de 1^{ère} intention est

- A- amoxicilline - acide clavulanique
B- céfixime
C- ciprofloxacine
D- cotrimoxazole
E- furadoïne

120- La durée du traitement prescrit est

- A- 1 jour
B- 3 jours
C- 5 jours
D- 7 jours
E- 10 jours

Cas clinique 14 :

Mr H.B, 60 ans, traité pour adénocarcinome du colon gauche par chirurgie et chimiothérapie adjuvante, présente au cours de son séjour pour cure de chimiothérapie, une dyspnée brutale avec une douleur médio-thoracique gauche. L'examen clinique montre une auscultation cardiaque et pulmonaire sans anomalies. La TA= 80/40 mmHg, FC= 125 bpm avec des marbrures au niveau des genoux. Une polypnée à 28 c/min avec un tirage intercostal inférieur. La SpO₂ = 88% à l'air ambiant. La radiographie du thorax ne montre pas d'anomalies et l'ECG montre une tachycardie sinusale à 125 bpm. Les gaz du sang artériels : pH=7.45, PaCO₂= 30 mmHg, PaO₂=52 mm Hg, SaO₂=87%. Troponine US=85 ng/L, NTproBNP = 3100 pg/ml.

Le diagnostic d'embolie pulmonaire est suspecté

121- Les examens complémentaires les plus rentables pour confirmer le

Le diagnostic d'embole pulmonaire est suspecté

121. Les examens complémentaires les plus rentables pour confirmer le diagnostic

- A. Scintigraphie pulmonaire
- B. **Echocardiographie**
- C. Dosage sérique de D dimères
- D. Echographie doppler veineux des membres inférieurs
- E. **Angioscanner thoracique**

122. Les mesures thérapeutiques que vous proposez dans ce cas sont

- A. **Anti coagulation curative**
- B. **Oxygénothérapie**
- C. Diurétiques
- D. **Thrombolyse**
- E. Dérivés nitrés

Cas clinique 15 :

Madame S âgée de 38 ans a pris 5 kg en 9 mois, malgré une activité sportive régulière. Elle se plaint de fatigue récente et ne prend plus plaisir à s'occuper de ses deux enfants âgés respectivement de 5 et 3 ans. Elle rapporte une chute des cheveux, des crampes musculaires à l'effort et même après arrêt de son activité sportive et la découverte fortuite d'une hypertrophie de la région antérieure du cou. Elle a un vitiligo depuis 10 ans. L'examen note un goitre diffus et homogène, une dépilation de la queue des sourcils et une infiltration cutanée. Les pouls périphériques sont bien perçus. La TA est à 16/10 cm Hg. Sa température est à 37°C. Elle est traitée par des statines depuis 3 mois pour une hypercholestérolémie. Le bilan montre une glycémie à 5 mmol/l, une calcémie à 2,4 mmol/l, une kaliémie à 4,2 mmol/l et une natrémie à 138 mmol/l.

123. Une hypothyroïdie est évoquée chez cette patiente devant :

- A- **L'asthénie**
- B- Les chiffres de tension artérielle
- C- **L'infiltration cutanée**
- D- **La prise de poids**
- E- **Les troubles des phanères**

124. L'étiologie de cette hypothyroïdie est :

- A- Une carence en iode
- B- **Une thyroïdite de Hashimoto**
- C- Une cause iatrogène
- D- Une cause centrale
- E- Une obésité

125. Les crampes musculaires chez cette patiente peuvent être dues à :

- A. Une hypokaliémie
- B. **Une atteinte musculaire secondaire à une hypothyroïdie**
- C. **Une toxicité des statines**
- D. Une artériopathie oblitérante des membres inférieurs
- E. Une hypoparathyroïdie